EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	:	87634
SERVICIO	:	MEDICINA HSC			
FECHA	:	2024-07-01 10:17:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA LUZ LAGOS ROMERO			RUN	: 6.897.872-6
F.Nac	: 05-12-1941	Edad	: 82 AÑOS, 6 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: EL MANZANO SAN NICOLAS			Comuna	: SAN NICOLAS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 51021654		
Fecha Ingreso	: 2024-06-27	Fecha Egreso	: 2024-07-01 10:17:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) EPOC sobreinfectado en tratamiento
2) SDRA 2° resuelta
3) HTA
4) DM2
5) Enf de alzheimer
6) Hipernatremia resuelta
7) AKI resuelta

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J15-NEUMONIA BACTERIANA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente cona ntec de3scritos, consulta en SU HSC el 25/06 por cuadro de disnea, CEG y desauracion en domicilio, a su ingreso se describe con P/A con tendencia a la hipotencion, subfebril, normocardica, con apoyo con O2 suplementario 3 lts/min por anricera.
Ex fisico pulmonar destaca crepitantes bibasales
Examenes de lab al ingreso -> Hb/Hcto 12.2/39.5, Gb 15, plaq 171000; crea 2,9; PCR 201,7; Na/K/Cl 160/5.4/127.
Se decide ingreso para manejo de patologia aguda.
Durante estancia se procede a volemizacion y terapia ATB de amplio espectro, con mejoria paulatina desde la esfera infecciosa y renal.

Paciente HDN estable, afebril, sin dolor, con buena tolerancia a alimentacion VO, sin episodios de nauseas y/o vomitos, diuresis 500 cc, deposiciones 200 cc disgregada, BH +1431
Examenes de lab -> crea 1; calcio 8,6, fosforo 2,7; lactato 1,4; Na/K/Cl 145/4.1/120; GSV pH 7,43
Ex fisico -> Vigil, CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Abdomen blando, distendido, RHA (+), sin signos de irritacion peritoneal
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

Paciente actualmente en su dia N° 5 hospitalizado, en condiciones de continuar tratamiento via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infeccioso/respiratorio: Con parametros inflamatorios en franco descenso, se continuara con terapia ATB via HODOm, control con examenes dentro de 48 hrs

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Régimen papilla hiposódcia asistida
3. Ceftriaxona 2 gr al dia EV por 3 dias
4. KNT respiratoria
5. Bromuro de ipratropio 4 puff c 6hrs por AC
6. Omeprazol 20 mg al dia VO por 3 dias
7. Salbutamol 2 puff c 6hrs
8. Examenes de control 03/06
9. COntinuar tratamiento cronico habitual

JEFE SERVICIO

DANIEL EDUARDO ACEVEDO
PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6